

GUÍA DE APLICACIÓN CLÍNICA — Técnica TIPP

Regulación emocional fisiológica rápida · DBT · Para uso del terapeuta en sesión

TIPP es un conjunto de cuatro estrategias de **regulación emocional rápida** desarrolladas por Marsha Linehan dentro de la DBT. Su objetivo es reducir la intensidad emocional extrema actuando directamente sobre la fisiología del paciente, **sin requerir capacidad reflexiva ni cognitiva para funcionar**. Es la habilidad de elección cuando la activación emocional es tan alta que el paciente no puede acceder a ninguna otra técnica.

LAS CUATRO ESTRATEGIAS

T TEMPERATURE Temperatura

BASE FISIOLÓGICA

El frío activa el reflejo de buceo de los mamíferos: respuesta autonómica que reduce la frecuencia cardíaca entre un 10 y un 25 % segundos y disminuye la activación del sistema nervioso simpático de forma inmediata.

APLICACIÓN

Sumergir la cara en agua fría 15-30 segundos, o sostener hielo en manos o muñecas. Sin acceso a agua: bolsa fría, lata fría o agua fría en la nuca. El agua debe ser fría pero no causar dolor.

Guión para el terapeuta:

«Cuando la emoción sea tan intensa que no puedas pensar con claridad, el frío le dice a tu cuerpo que se calme sin que tengas que hacer nada mental. No necesitas creerlo ni entenderlo — es una respuesta automática de tu sistema nervioso.»

Contraindicaciones: Trastornos cardiovasculares que contraindiquen cambios bruscos de temperatura. Consultar con el equipo médico en caso de duda.

I INTENSE EXERCISE Ejercicio intenso

BASE FISIOLÓGICA

La activación emocional extrema genera preparación corporal para luchar o huir. Si no encuentra salida, el sistema nervioso permanece en alarma. El ejercicio intenso breve metaboliza esa activación completando el ciclo de respuesta de estrés.

APLICACIÓN

Dos minutos de alta intensidad son suficientes: correr en el sitio, sentadillas, saltos, subir y bajar escaleras o flexiones. La intensidad es el factor determinante — la actividad moderada no produce el mismo efecto.

Guión para el terapeuta:

«Tu cuerpo está preparado para correr o pelear aunque no haya ningún peligro real. Si le damos esa salida física durante dos minutos, la alarma se apaga sola. No tienes que entender por qué funciona — solo probar.»

Contraindicaciones: Lesiones físicas activas o condiciones médicas que limiten el ejercicio intenso. Adaptar la actividad al estado físico del paciente.



P

PACED BREATHING

Respiración acompasada

BASE FISIOLÓGICA

Exhalar más lento que inhalar activa el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático, produciendo reducción real de la frecuencia cardíaca y de la activación simpática. No es relajación sugestiva — es regulación autonómica directa.

APLICACIÓN

Inhalar 4 segundos · exhalar 6-8 segundos. Repetir 2-3 minutos. La exhalación debe ser siempre más larga — ese es el mecanismo activo. Si el paciente no puede contar: exhalar como si soplara una vela muy despacio sin apagarla.

Guión para el terapeuta:

«No tienes que vaciar los pulmones ni hacer nada especial. Solo deja que el aire salga más despacio de lo que entró. Tu sistema nervioso hace el resto de forma automática.»

Consideración clínica: En pánico o hipocondría la atención a la respiración puede aumentar la ansiedad. Introducir con ojos abiertos orientados al exterior, o sustituir temporalmente por temperatura.

P

PROGRESSIVE RELAXATION

Relajación progresiva

BASE FISIOLÓGICA

La tensión muscular crónica es una respuesta somática frecuente en alta activación sostenida. La tensión y liberación muscular consciente interrumpe ese patrón y devuelve al sistema nervioso información de seguridad desde el cuerpo.

APLICACIÓN

Tensar cada grupo muscular 5 segundos y soltar 10, atendiendo al contraste. Versión breve (4 grupos): manos, brazos, abdomen, piernas — menos de 5 minutos. Versión completa: 8-16 grupos según protocolo de Jacobson.

Guión para el terapeuta:

«Vamos a tensar y soltar grupos de músculos. Primero aprieta los puños todo lo que puedas durante cinco segundos. Ahora suelta completamente y nota la diferencia. Tu cuerpo aprende así cómo se siente realmente relajado, y ese contraste es el que produce el efecto.»

Consideración clínica: En trauma corporal o disociación somática, empezar por extremidades distales (manos y pies) antes de zonas centrales. Preguntar qué zonas se sienten seguras para trabajar.